RUTA CLÍNICA: DIABE

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E
Crecemos para cuidar tu Salud!

1. INGRESO DEL PACIENTE

Tamizaje: Para toda población general **≥** 35 años

O antes si:

Factores de Riesgo (FR): IMC ≥25, Antecedente familiar DM II, Enfermedad Cardiovascular Establecida, HTA, Dislipidemia, Síndrome Ovario Poliquístico (SOP), DM Gestacional. FINDRISC ≥12

Escala FINDRISC: doi.org/10.53853/encr.12.2.905 //doi.org/10.53853/encr.12.2.905

Paciente con Síntomas Cardinales: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso no intencional.

Glicemia Ayunas 100-125 mg/dl
HbA1C 5.7% a 6.4%
Poscarga de 75 gr 140-199 mg/dl

Diagnóstico de PREDIABETES

SI:
- Seguimiento con pruebas dx* a los 6-12 meses
- Indicar hábitos Saludable, **PERO** si persistencia de HbA1C > 6%, IMC ≥35, <60 años, Diabetes gestacional previa, progresión pese a cambios de estilo de vida, otros factores de RCV, considerar Metformina.

NO:
- Seguimiento paraclínico en 3 años

¿Criterios Diagnósticos DM II?

Con cualquiera de los siguientes:

Glicemia en ayunas **≥ 126** mg/dL

Glicemia a las 2 horas poscarga de 75 g **≥ 200** mg/dL

HbA1c **≥ 6,5%**

Glicemia al azar **≥ 200** mg/dL **con síntomas** clásicos o crisis hiperglucémica.

Paciente **sin** sintomatología requiere **prueba confirmatoria adicional**

Si se obtiene una prueba alterada y otra en rangos normales, repetir prueba con resultado alterado

- Si Prueba Adicional está alterada
- Si Prueba Adicional es normal

2. Diagnóstico Diabetes Mellitus tipo 2

2.1 Solicitar paraclínicos iniciales → HbA1C, perfil lipídico (CT, HDL, TG, LDL), creatinina sérica, uroanálisis, microalbuminuria en orina parcial (RA/C), creatinina en orina parcial

2.2 Calcular Riesgo Cardiovascular → Según el Consenso Colombiano para el diagnóstico y tratamiento de dislipidemias en adultos 2024

2.3 Inicie Tratamiento y remisión a → Programa de crónicos, nutrición, psicología, odontología y enfermería (si considera apoyo educativo en inicio de insulina)

3. TRATAMIENTO



Para todos los pacientes inicie con cambios de hábitos de vida saludable, educación, apoyo y análisis de determinantes de la salud → Alimentación saludable individualizada, Actividad física ≥150 min/semana / Ejercicio de resistencia ≥2-3 veces/semana, Pérdida de peso 5-10% (mínimo clínicamente significativo)/ 10-15% en alto riesgo, Cese de tabaquismo y alcohol.

Verificar Criterios Inicio de Insulina^{++}

- SI → Avance a la sección de esquemas de insulina
- NO

¿Paciente con Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica Establecida/ Alto Riesgo Enfermedad Cardiovascular, Insuficiencia cardiaca, Enfermedad Renal Crónica u Obesidad?

- SI → Continúe Protocolo**
- NO

¿HbA1c >1% sobre la meta?

- NO → Inicie terapia con Metformina
- SI → Inicie Terapia Combinada Metformina + iSGLT2 (o iDPP4). Evalúe según objetivo

HbA1c persiste fuera de metas

Evite Inercia terapéutica. Control cada 3-6 meses.



Direccionar paciente a Programa de Riesgo Cardiovascular e iniciar tratamiento

:TES MELLITUS TIPO 2

Ámbito: Consulta externa
Dirigido a: Médico general, Enfermería, Especialistas

3.1. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

Continúe Protocolo**

Objetivo: Reducción del Riesgo Cardiovascular y Renal

Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica Establecida/ Alto Riesgo Enfermedad Cardiovascular

aGLP-1 ó iSGLT2

Si HbA1c no controlada

Considere Iniciar terapia combinada con aGLP1 + iSLGT2

Insuficiencia Cardiaca

Enfermedad Renal Crónica

iSLGT-2
**En ERC Inicio si TFG >20 mL/min/1.73

Si persiste Albuminuria pese a IECA/ARAII

Considere uso Finerenona

Objetivo: Control, Peso y Glucemia

Control Peso: IMC ≥ 27

Eficacia Alta: aGLP1: Tirzepatida, Semaglutida, Dulaglutida, Liraglutida.
Eficacia Intermedia: iSGLT2.
Neutral: Metformina o iDPP-4

HbA1c persiste fuera de metas

Control Glucémico

Eficacia Muy Alta: aGLP1
Eficacia Alta: Metformina, iSLGT2
Eficacia Intermedia: iDPP4

HbA1c persiste fuera de metas

Considere Inicio de Insulinas++

Derivar a Medicina Familiar

Evalué la necesidad de tercer hipoglucemiante oral vs terapia inyectable

Se recomienda inicio de INSULINA BASAL + aGLP-1 (Antes de Esquema Basal Bolo)

Criterios de insulinización++

Glucosa ≥300 mg/dL o HbA1c >10%. Evaluar la posibilidad de Inico GLP 1*

Pérdida de peso involuntaria, poliuria/polidipsia intensas, cetonuria o cetonemia

Insulinopenia (LADA/Fenotipo tipo1), crisis hiperglucémica, fracaso terapéutico, hiperglucemia persistente.

Situaciones especiales (corticoides, enfermedad aguda), contraindicación a otros fármacos (ERC avanzada)*

Para esquema de insulina tenga en cuenta que:

Esquema de Insulina Basal: Glargina 10 Ul/día o 0.1- 0.2 U/kg/día

Esquema Basal Plus: 4 unidades o 0.1 U/kg o 10% de la dosis basal. Se aplica en la comida principal (mayor carga glucémica).

Esquema Basal Bolo: 0.3-0.5 U/kg/día. En resistencia importante hasta 0.5–0.7 U/kg. Distribución: 50% basal y 50% prandial, dividido en 3 comidas.

Tenga en cuenta que

Si hipoglucemia reducir dosis entre un 10-20%

HIPOGLICEMIA
En episodio sintomático educar a la familia sobre CONSUMO de carbohidrato como: 2 cucharadas de azúcar con agua ó jugo de frutas 4-6 oz

Toma de Glucometría a los 15 minutos, si persiste repetir consumo de carbohidrato

Tercera toma con glucometría en hipoglucemia acudir a urgencias

Clasificación:
Nivel 1: Glicemia < 70mg/dL y ≥54mg/dL
Nivel 2: Glicemia < 54 mg/dl
Nivel 3: Cualquier evento que requiere asistencia externa para corrección.

Derivar a Medicina Familiar

4.1 CONTROL DE TRATAMIENTO

4.1 REVISIÓN DE ADHERENCIA → Realizar cuestionario MORISKY-GREEN

No.	Pregunta	
1	¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?	SI/NO
2	¿Olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas?	SI/NO
3	Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?	SI/NO
4	Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?	SI/NO

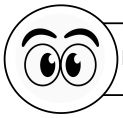
Interpretación	
Cumplimiento	4 respuestas NO
No cumplimiento	Mínimo 1 respuesta SÍ

→ Derivar a Psicología y Medicina Familiar

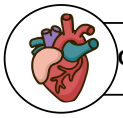
4.2 EVALUACIÓN DE COMPLICACIONES Y DERIVACIONES



Valoración Medicina Familiar → Alto y muy alto RCV, NO metas HbA1c con 3 hipoglucemiantes, alta variabilidad glucémica, neuropatía diabética/pie diabético, NO adherente, Enfermedad Renal estadio II y IIIA



Desde Diagnostico de DM2 derivar a Oftalmología → Valoración mínimo cada 1-2 años

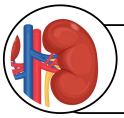


Cardiopatía: Evaluar Signos y Síntomas asociados → Considerar realización de Ecocardiograma y valoración por Cardiología

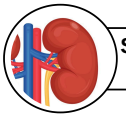


Enfermedad Arterial Periférica (EAP): Evaluar pulsos distales y signos asociados. Clasificación de FONTAINE → Considerar Valoración por Cirugía Vascular

Clasificación **FONTAINE**: https://www.revespcardiol.org/es-enfermedad-arterial-periferica-aspectos-fisiopatologicos-articulo-13109651



Si TFG <60 ml/min/1.73m2 (primera toma) o Si RA/C es > 30mg/g (primera toma) → Toma de nueva creatinina en 3 meses
Toma de nueva microalbuminuria + creatinuria en 3 meses



Si ERC IIIB, IV o V y/o si RA/C > 300mg/g: indicar proteinuria en orina de 24 horas y derivar a nefrología → Valoración por Nefrología



Neuropatía diabética/pie diabético:
Evalué Signos y Síntomas. Descartar otras causas (toxinas alcohol, déficit Vit B12, ERC, Medicamentos Neurotoxicos, Malignidad, Infecciones, Vasculitis)
Realizar evaluación integral pies. →

Evaluación Pies:

- Úlceras,deformidades, sensación vibratoria con diapasón de 128Hz, temperatura y prueba de Monofilamento
- Normal: Control Anual y Educación



Cribado Positivo: Neuropatía Sensorial Cuando; No se perciban 4 o más de los puntos examinado, o 1 o mas de (pulpejo primer dedo, cabezas del primer y quinto metatarsiano)



Otras: Nutrición: Sobrepeso/obesidad., Enfermería: Inicio de Insulinas, Psicología: No Adherencia

4.3 DEFINIR METAS DE TRATAMEINTO

Metas Individualizadas

- HbA1C
  - Población General → HbA1C <7%
  - Paciente con larga expectativa de vida, Bajo riesgo Hipoglucemia, Pocas Comorbilidades → HbA1C <6.5%
  - Adultos Mayores >60 años con: Perfil de Fragilidad, Con Múltiples comorbilidades → HbA1C <7-8%
- Glucometrías → En ayunas 80-130 mg/dl
  Después de comidas hasta 180 mg/dl sin Hipoglicemias
  → **Control Trimestral. Indicar Control Mensual si**: Inicio de Insulinoterapia, no controlado, Hipoglucemias.
- Otras Metas de Tratameinto → Colesterol LDL : Según RCV
  Triglicéridos < 150 mg/dl
  RAC: <30 mg/gr
  Pérdida de peso 5-15%
  Perímetro abdominal: M<80 cm y H <90 cm
  TA <130/80 **ver vía HTA**

RIESGO CARDIOVASCULAR



4.4 Paraclinicos de Control

PARACLÍNICO	FRECUENCIA ESTANDAR
HbA1C/Glicemia en Ayunas	Cada 6 meses (SI en metas) Cada 3 meses (No Metas/Ajustes)
Perfil Lipídico	Anual (En metas) Cada 3-6 meses (No metas/Ajustes)
Relación albúmina/creatinuria (RA/C) y Creatinina Serica	RAC <30 mg/g anual RAC 30-300 mg/gr Repito en 3 meses y confirmo ERC RAC>300 mg/g Indicar Proteinuria en 24 horas.
Uroanálisis	Anual (SI en metas) Cada 3-6 meses si hallazgo anormal

5. Revisar medicamentos, contraindicaciones y efectos secundarios relevantes

Medicamentos	Dosis Mínima - Maxima	Efectos Secundarios	Contraindicación/Precaución
Metformina	500 - 2000 mg/dia	Efectos Gastrointestinal, Diarrea, Acidosis Láctica.	TFG <45 ml/min/1.73m^2 no iniciar, si TFG<30 ml/min/1.73m^2 retirar. Cirrosis, Hipoxemia (EPOC O2 requiriente, ICC NYHA IV, Déficit B12
Dapaglifozina	5 - 10 mg/dia	Candidiasis Vulvovaginal, Balanitis, Hipotensión Ortostática, puede reducir TFG 3-5 m/min/1,73 m^2	TFG <25-30 ml/min/1.73m^2. Suspender 24 hr antes de cirugía electiva. Evitar si cetoacidosis previa. Deshidratación.
Empaglifozina	10 - 25 mg/dia	Candidiasis Vulvovaginal, Balanitis, Hipotensión Ortostática, puede reducir TFG 3-5 m/min/1,73 m^2	TFG <20 ml/min/1.73m2, Infecciones genitourinarias recurrentes, Cetoacidosis previa.
Vidagliptina	50 - 1000 mg/dia	Cefalea, aumento de transaminasas	AST/ALT >3 veces el limite superior: Hepatopatía, Cirrosis.
Sitagliptina	25 - 100 mg/dia	Cefalea, Pancreatitis	Pancreatitis previa, Ajustar Según TFG
Linagliptina	5 mg/dia	Cefalea, No requiere Ajuste renal, Nasofaringitis, IRA, Hepatitis.	Pancreatitis previa (Precaución), Inductores CYP3A4 (rifampicina).
Liraglutida	0.6 - 1.8 mg/dia	Efectos Gastrointestinales, Pérdida de Peso, Retinopatía Diabética	Pancreatitis, Gastroparesia, Enf GI severa, Historia de CA medular de tiroides TF <15 ml/min/m^2
Semaglutida	0.25 - 2 mg/sem	Efectos Gastrointestinales, Artralgias	Pancreatitis, Retinopatía diabética proliferativa, GI severa, CA medular tiroides
Dulaglutida	0.75 - 1.5 mg/sem	Efectos Gastrointestinales, Artralgias	Pancreatitis, Enf GI severa, CA medular de tiroides
Finerenona	10 mg/día en TFG 25-60 ml/min/1.73m^2 o 20 mg/día si TFG >60 - Máxima 20 mg/día	Hiperkalemia (Evitar combinación con Mineralocorticoides)	TFG <25 ml/min/1.73m2, potasio >5 mmol/l, Insuficiencia suprarrenal, uso concomitante de inhibidores de CY3A4, Hepatopatía Grave.

6. PRECAUCIONES ADICIONALES

NO hacer uso conjunto de iDPP4 y aGLP1 ya que actúan sobre la misma vía incretina, sin brindar mayor beneficio 

HIPERGLUCEMIA
Glucometría > 250mg/dL + Síntomas → Boca seca, sed extrema, micción frecuente, debilidad general, aliento con olor afrutado, náuseas y vómitos, dolor abdominal, respiración profunda y rápida, confusión → Acudir a Urgencias

Referencias:
American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S1–SXXX.
Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE). Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en Colombia 2025. Bogotá: ACE; 2025.